

Anemia ferropriva na criança · profilaxia

Ferropenia é a causa nº 1 de anemia na infância. Profilaxia com ferro e alimentação adequada previnem; tratamento confirma-se pela resposta reticulocitária.

Profilaxia (MS — conceito)

Dica - Profilaxia (MS — conceito)

Suplementação preventiva de ferro em lactentes conforme idade gestacional e aleitamento — memorize o princípio: prematuros e termo em risco recebem ferro profilático.

Identifique risco (prematuridade, leite de vaca precoce, baixa ingestão) e trate com ferro oral.

Anemia ferropriva

Risco -> diagnostico -> ferro

Rastrear risco

prematuro / dieta

Lab

Hb, VCM, ferritina

Ferro oral

3-6 mg/kg/dia

Tratamento

- Ferro elemental ~3–6 mg/kg/dia; longe de leite/cálcio se possível
- Resposta: !reticulócitos em ~1–2 semanas; Hb sobe em ~1 mês
- Manter 2–3 meses após normalizar Hb para repor estoques
- Investigar perda/ sangramento se refratária ou idade atípica

Labs típicos

Exame | Achado

VCM/HCM | Baixos

RDW | Alto

Ferritina | Baixa

Saturação de transferrina | Baixa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Leite de vaca integral precoce (<1 ano) é fator clássico de ferropenia/enteropatia. Não feche talassemia sem ferritina — e vice-versa.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Labs clássicos (VCM baixo, ferritina baixa, RDW alto) e cortes de Hb por idade fecham anemia ferropriva e a resposta ao ferro.

Microcítica hipocrômica + estoques baixos. Resposta reticulocitária confirma terapêutica.

Labs da ferropriva

Padrao classico

Hb baixa para idade	+
VCM / HCM baixos	+
RDW alto	+
Ferritina baixa	++
Sat. transferrina baixa	+
Reticulocitos sobem c/ ferro	confirma

Ferritina baixa e o melhor estoque simples

Valores de referência variam por guia; memorize a ideia: RN alto !' nadir lactente !' sobe na infância.

Cortes de Hb (ideia)

Por faixa etaria

- 1 RN termo: Hb tipicamente alta
- 2 2-3 meses: nadir fisiologico
- 3 6-59 meses: corte classico ~11 g/dL
- 4 5-11 anos: corte um pouco maior
- 5 Adolescente: difere por sexo

Usar tabela local / OMS do servico

Tratamento

Item | Conduta

Dose | Ferro elemental ~3–6 mg/kg/dia

Resposta | Reticulócitos !' em 1–2 semanas; Hb sobe ~1 mês

Duração | 2–3 meses após normalizar Hb (repor estoques)

Profilaxia | Prematuros e lactentes em risco (princípio MS)

Fatores de risco

- Prematuridade / baixo peso
- Leite de vaca integral precoce (<1 ano)
- Baixa ingestão de ferro / desmame inadequado
- Perda digestiva oculta se refratária

Armadilha

Atencao - Armadilha

Não feche talassemia minor sem ferritina — e não ignore ferropenia só porque há 'história familiar de microcitose'.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1